

1. Накладання оклюзійної пов'язки; рана груд кл

Сценарій.

Ви черговий хірург лікарні. До приймального відділення самостійно звернулася пацієнтка 47 років з колото-різаною раною грудної клітки зліва.

Скарги: на задиху, наявність ножового поранення грудної клітини зліва, загальну слабкість, втрату свідомості.

Анамнез захворювання: Пів години назад після сварки з сусідом, отримала поранення грудної клітки зліва.

Анамнез життя: Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена. В анамнезі лапаротомія з приводу перфоративної виразки шлунка.

Об'єктивно: загальний стан важкий, свідомість збережена, положення горизонтальне. Шкіра бліда. Ріст 167 см, вага 76 кг. ЧДР – 26 за хвилину. При пальпації грудна клітина болісна у зоні поранення в 5-му міжребер'ї по середній пахвовій лінії зліва. Підшкірної емфіземи немає. При порівняльній перкусії праворуч ясний легеневий звук, зліва тимпаніт. При аускультатії праворуч жорстке дихання, зліва не вислуховується. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця приглушені ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС=Пс=112 за хв., АТ - 90/50 мм рт.ст. Живіт невдутий, приймає участь у акті дихання. При пальпації м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом Щоткіна-Блюмберга негативний. Аускультативно - перистальтика ослаблена. Ділянка попереку без патології. Нирки не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

Додатково:

Клінічний аналіз кров

Показник	Значення	Референтні значення
Гемоглобін г/л	90	130-160г/л – для чоловіків 120-140г/л - для жінок
Еритроцити $10^{12}/л$	3,0	4,0-5,0 $\times 10^{12}/л$ – для чоловіків 3,9-4,7 $\times 10^{12}/л$ – для жінок
Кольоровий показник	0,7	0,85-1,15
Тромбоцити $10^9/л$	220	180-320 $\times 10^9/л$
Лейкоцити $10^9/л$	10,5	4,0-9,0 $\times 10^9/л$
- лімфоцити%	14	19-37%
- еозінофіли %	-	0,5-5,0%
- палочкоядерні нейтрофіли %	6	0-5,0%

- сегментоядерні нейтрофіли %	75	47,0-72,0%
- моноцити %	5	3,0 – 11,0 %
ШОЕ	5	1 – 10 мм/ч – для чоловіків 2 – 15 мм/ч – для жінок

Оглядова рентгенографія органів грудної клітини



12. Інструкція для стандартизованого пацієнта (за необхідності, якщо це передбачено умовами роботи на станції).

№п/п	Дії	Текст
1.Комунікативні навички		
1.1	Привітатися.	Доброго дня.
1.2	Ви даєте свою згоду на проведення клінічного обстеження?	Так
Збір скарг та анамнезу		
2.1	Які у Вас скарги?	На задуху, наявність ножового поранення грудної клітини зліва , загальну слабкість, втрату свідомості
2.2	Коли з'явилися скарги, що з Вами трапилось?	Пів години назад після сварки з сусідом, отримала поранення грудної клітки зліва.
2.3	Якими захворюваннями перехворіли? Чи є алергія? Чи були операції?	Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Огляд з верифікацією виявлених патологічних змін.	Я проводжу огляд з верифікацією виявлених патологічних змін.Я оглядаю пацієнтку та виявляю колото-різану рану в ділянці 5-го міжребер'я по середній пахвовій лінії зліва. Шкіра бліда, пацієнтка в горизонтальному положенні. Дихання поверхнєве, утруднене, спостерігається виражена задишка. Ознаки гіпоксії — периоральний ціаноз.
3.2	Пальпація з верифікацією виявлених патологічних змін	Я виконую пальпацію з верифікацією виявлених патологічних змін.Пальпація в зоні поранення викликає різку болючість. Ознак підшкірної емфіземи не виявлено. Болісність локалізується навколорани, грудна клітка деформована в ділянці ураження.

3.3	Перкусія з верифікацією виявлених патологічних змін	Я здійснюю перкусію з верифікацією виявлених патологічних змін. При перкусії — праворуч ясний легеневий звук, зліва — тимпанічний, що свідчить про наявність повітря у плевральній порожнині та можливий напружений пневмоторакс.
3.4	Аускультация з верифікацією виявлених патологічних змін	Я виконую аускультацию з верифікацією виявлених патологічних змін. При аускультатії правої легені — жорстке дихання, зліва — дихання не вислуховується.
4.Діагностика		
4.1	Проаналізувати клінічний аналіз крові	Я аналізую клінічний аналіз крові .Я виявляю анемію (гемоглобін 90 г/л, еритроцити $3,0 \times 10^{12}/л$, кольоровий показник 0,7), що свідчить про можливу внутрішню або зовнішню кровотечу. Лейкоцитоз ($10,5 \times 10^9/л$) та нейтрофіліоз можуть свідчити про стресову або запальну реакцію.
4.2	Проаналізувати оглядову рентгенографію органів грудної клітини	Зліва рівень рідини у плевральній порожнині. Над рівнем рідини – повітря.
4.3	Встановити попередній клінічний діагноз	Відкрита травма грудної клітини зліва, гемопневмоторкас зліва.
5. Визначення тактики ведення та лікування		
5.1	Медикаментозна терапія, фізіотерапія, особливості харчування	Госпіталізація в торакальне відділення. Усадити в напівсидяче положення. Накладання оклюзійної пов'язки. Пункція плевральної порожнини з метою декомпресії (2 мж). Дренування
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		

6.1	Рекомендувати профілактичні заходи	Я рекомендую уникати різких рухів головою, не займатися самостійним вправлянням хребців. У майбутньому — регулярні заняття лікувальною фізкультурою, укріплення м'язового каркасу шиї, профілактика повторних травм.
7.Інше		
7.1	Інформування пацієнта про можливі ризики хвороби	Я інформую пацієнта про можливі ризики травми . Я поясню пацієнту ризики ускладнень — пошкодження спинного мозку, стійкий больовий синдром, неврологічні порушення. Надаю повну інформацію про необхідність дотримання лікувального режиму та повторного огляду.

Чек-лист до практичної навички «Накладання оклюзійної пов'язки»

№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування лікар-пацієнт, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробка рук антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Обрати необхідну пов'язку	Виконати